

Convulsão febril · abordagem

Convulsão febril ocorre entre ~6 meses e 5 anos com febre, sem infecção de SNC prévia. A maioria é simples e autolimitada; o foco é ABC, tempo de crise e sinais de meningite.

Crise ativa

Dica - Crise ativa

Se >5 minutos: benzodiazepínico (midazolam/diazepam conforme via disponível). Proteja via aérea, glicemia capilar e não force objetos na boca.

Ramificação: simples !' tranquilizar + antitérmico; complexa/atípica !' investigar e neurologia.



Quando temer SNC / outra causa

- Toxemia, nuchalidade, petéquias, fontanela abaulada
- Lactente muito jovem, convulsão febril atípica ou déficit pós-ictal prolongado
- Vacinação/estado vacinal e epidemiologia (considerar meningite)
- Primeira crise afebril: não rotular como 'febril'

Conduta após a crise

Cenário | Conduta

Simple típica | Observação, orientação, antitérmico; EEG/TC não rotineiros

Complexa | Avaliação mais ampla; imagem/EEG selecionados

Suspeita de meningite | Punção / ATB — não atrasar se grave

Status epilepticus | Protocolo de status + UTI

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Anticonvulsivante de manutenção profilático não é rotina após convulsão febril simples. Educar os pais sobre recorrência e manejo da crise vale mais do que medicar 'para prevenir'.

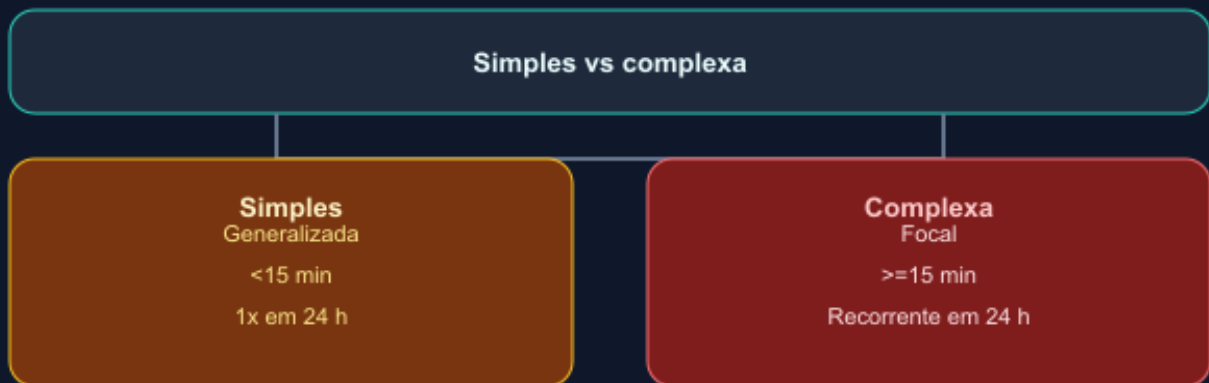
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Crítérios de convulsão febril simples vs complexa definem investigação, internação e o risco de epilepsia futura.

Simples: generalizada, <15 min, única em 24 h, 6 meses–5 anos, recuperação completa.

Convulsao febril



Fora da faixa etária, déficits focais ou múltiplas crises !' tratar como complexa/investigar mais.

Critérios - simples

Todos devem caber

- 1 Idade típica 6 meses a 5 anos
- 2 Febre presente
- 3 Crise tonico-clonica generalizada
- 4 Duração < 15 minutos
- 5 Única em 24 h
- 6 Exame neurológico normal após

Sempre excluir meningite se duvida

Conduta prática

Situação | Conduta

Crise ativa | ABC; BZD (midazolam/diazepam) se >5 min

Simples típica | Orientação; sem EEG/TC de rotina

Complexa / déficit | Investigar; considerar internação/imagem

Suspeita de SNC | PL/ATB conforme clínica — não 'febre = só CF'

Pontos de prova

- Profilaxia contínua com anticonvulsivante não é rotina na CF simples
- Diazepam intermitente em febre: uso selecionado; educar pais sobre recidiva
- Primeira crise afebril " convulsão febril

Armadilha

Atencao - Armadilha

Lactente <6 meses com 'crise febril' merece investigação ampla — meningite/metabólico até prova em contrário.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1